

BRK Funkübung Feucht Patientenkarte P1	ÜBUNG
--	--------------

Szenario: VU - Radfahrer vs. PKW (schweres Trauma)

Name	Lennart Voigt
Alter	27 Jahre
Geschlecht	männlich
Fundort (what3words)	///erstes.arbeitswelt.spülmittel

Vitalparameter	
RR	82/54 mmHg
HF	132 /min
AF	30 /min
SpO2	88% (RA)
Temp	36.0 C
GCS	12 (E3 V4 M5)
BZ	118 mg/dl

Beschwerden / Befund
• Nach Kollision mit PKW, kurze Bewusstlosigkeit laut Zeuge. • Starke Blutung am rechten Oberschenkel (Blut sickert durch Kleidung). • Atemnot, starke Schmerzen Brust/Becken, wirkt verwirrt und kaltschweißig.

ABCDE Schema (Befundorientiert)

A	Spricht einzelne Worte, Atemwege aktuell frei. Blut im Mundwinkel/Helmvisier; Aspirationsgefahr bei Vigilanzminderung.
B	Tachypnoe, Dyspnoe. SpO2 88% an Raumluft. Thoraxschmerz, flache Atmung, Einsatz Atemhilfsmuskulatur.
C	Kalte, blasse Haut. Kapillarfuellung > 4 s. Massive Blutung Oberschenkel, Puls peripher schwach, RR 82/54.
D	GCS 12, desorientiert, verzögerte Antworten. Pupillen isokor, lichtreagibel.
E	Mehrere Schuerfwunden/Prellmarken, Verdacht auf Becken-/Thoraxtrauma. Auskuehlung droht (nass/kalter Wind).

SAMPLER Anamnese

S	Symptoms: Schmerzen Brust/Becken 8/10, Schwindel, Atemnot.
A	Allergies: Keine bekannt (NK).
M	Medications: Keine regelmaessigen Medikamente (laut Pat./Zeuge).
P	Past medical history: Bisher gesund, keine bekannten Vorerkrankungen.
L	Last intake: Letzte Nahrungsaufnahme: Sandwich vor ca. 2 h.
E	Events: Radfahrer von PKW erfasst, Sturz auf rechte Seite, kurze Bewusstlosigkeit.
R	Risk factors: Kein Antikoagulans bekannt; Helm getragen.

Interne Übungsunterlage - Patientenkarte P1 - Stand: 2026-02-24

Patientenkarte P1 - Rückseite

DIES IST EINE ÜBUNG DES BRK

**Bitte lassen Sie diesen Zettel an der Position
liegen.**

Vielen Dank für Ihre Unterstützung.

Hinweis: Keine Gefahr. Es handelt sich nicht um einen echten Notfall.

In einem echten Notfall: 112

BRK Funkübung Feucht Patientenkarte P2	ÜBUNG
--	--------------

Szenario: Sturz beim Skateboardfahren (Arm-/Handgelenksverletzung)

Name	Elzbieta Szczepaniak	Vitalparameter	
Alter	19 Jahre	RR	128/78 mmHg
Geschlecht	weiblich	HF	104 /min
Fundort (what3words)	///vorweisen.kanone.möchte	AF	20 /min
		SpO2	99% (RA)
		Temp	36.8 C
		GCS	15
		BZ	102 mg/dl

Beschwerden / Befund
• Sturz beim Skateboardfahren, auf die ausgestreckte rechte Hand gefallen. • Starke Schmerzen und Schwellung am rechten Handgelenk, Bewegung kaum moeglich. • Schuerfwunde Knie; kein Hinweis auf Kopfaufprall, Helm getragen.

ABCDE Schema (Befundorientiert)

A	Atemwege frei, spricht klar. Kein Erbrechen, keine Schluckstoerung.
B	Atmung unauffaellig, keine Dyspnoe. SpO2 99% an Raumluft.
C	Kreislauf stabil. Schmerzbedingt tachykard. Rechtes Handgelenk deutlich druckschmerzhaft, Schwellung; periphere Durchblutung/Sensibilitaet erhalten.
D	Wach, orientiert, GCS 15. Kein Schwindel, keine neurologischen Ausfaelle.
E	V.a. distale Radiusfraktur/rechte Handgelenksverletzung. Schuerfwunden Knie/Hand. Waermemanagement ok.

SAMPLER Anamnese

S	Symptoms: Handgelenksschmerz rechts 9/10, Bewegungseinschraenkung.
A	Allergies: Penicillin (Hautausschlag).
M	Medications: Keine.
P	Past medical history: Keine bekannten Vorerkrankungen.
L	Last intake: Energy-Drink vor ca. 1 h.
E	Events: Sturz vom Skateboard, Abstuetzen mit rechter Hand.
R	Risk factors: Keine Antikoagulation; kein Alkoholhinweis (laut Patientin).

Interne Übungsunterlage - Patientenkarte P2 - Stand: 2026-02-24

Patientenkarte P2 - Rückseite

DIES IST EINE ÜBUNG DES BRK

**Bitte lassen Sie diesen Zettel an der Position
liegen.**

Vielen Dank für Ihre Unterstützung.

Hinweis: Keine Gefahr. Es handelt sich nicht um einen echten Notfall.

In einem echten Notfall: 112

BRK Funkübung Feucht Patientenkarte P3	ÜBUNG
--	--------------

Szenario: Atemnot (bekannte COPD, Inhalator ohne Effekt)

Name	Hakan Yilmaz
Alter	62 Jahre
Geschlecht	männlich
Fundort (what3words)	///wunder.untersuchen.lacke

Vitalparameter	
RR	154/88 mmHg
HF	112 /min
AF	28 /min
SpO2	88% (RA)
Temp	36.8 C
GCS	15
BZ	126 mg/dl

Beschwerden / Befund
• Bekannte COPD, seit ca. 1 h zunehmende Atemnot, spricht in kurzen Sätzen. • Inhalator genutzt, bisher ohne ausreichenden Effekt. Pfeifende Atmung. • Kein Thoraxschmerz, kein Sturz, kein Fieber bekannt.

ABCDE Schema (Befundorientiert)

A	Atemwege frei, kann sprechen (kurze Sätze). Kein Fremdkörper, kein Erbrechen.
B	Dyspnoe, Tachypnoe, Giemen. SpO2 88% an Raumluft. Einsatz Atemhilfsmuskulatur.
C	Kreislauf kompensiert, tachykard. Haut warm, leicht schwitzig.
D	Wach und orientiert, wirkt ängstlich. Keine fokale-neurologischen Ausfälle.
E	Keine sichtbaren Verletzungen. Umgebung: Wohnung/Treppenhaus (körperliche Belastung als Auslöser möglich).

SAMPLER Anamnese

S	Symptoms: Atemnot, pfeifende Atmung, Erschöpfung.
A	Allergies: Keine bekannt.
M	Medications: COPD-Inhalatoren (z.B. SABA/LABA/LAMA) laut Patient; heute mehrfach genutzt.
P	Past medical history: COPD, Raucheranamnese.
L	Last intake: Mittagessen vor ca. 4 h.
E	Events: Atemnot nach Treppensteigen/Belastung, Inhalator ohne ausreichenden Effekt.
R	Risk factors: Raucher; wiederholte Exazerbationen in der Vergangenheit (laut Patient).

Interne Übungsunterlage - Patientenkarte P3 - Stand: 2026-02-24

Patientenkarte P3 - Rückseite

DIES IST EINE ÜBUNG DES BRK

**Bitte lassen Sie diesen Zettel an der Position
liegen.**

Vielen Dank für Ihre Unterstützung.

Hinweis: Keine Gefahr. Es handelt sich nicht um einen echten Notfall.

In einem echten Notfall: 112

BRK Funkübung Feucht Patientenkarte P4	ÜBUNG
--	--------------

Szenario: Leichter Verkehrsunfall an stark befahrener Kreuzung

Name	Kevin Schäfer
Alter	31 Jahre
Geschlecht	männlich
Fundort (what3words)	///zumal.genügt.hellbraun

Vitalparameter	
RR	138/84 mmHg
HF	92 /min
AF	18 /min
SpO2	98% (RA)
Temp	36.5 C
GCS	15
BZ	101 mg/dl

Beschwerden / Befund
• Leichter Auffahrunfall an stark befahrener Kreuzung, Airbag ausgelöst. • Patient klagt ueber leichte Nackenschmerzen und kleine Schuerfwunde an der Stirn, sonst o.k. • Vor Ort: deutlicher Geruch nach Benzin, unter einem PKW laeuft Fluessigkeit aus; Verkehr staut sich, keine Absicherung.

Hinweis
• Patient moechte nicht in ein Krankenhaus. • Nach aktuellem Befund und Vitalparametern spricht medizinisch nichts dagegen.

ABCDE Schema (Befundorientiert)

A	Atemwege frei, spricht normal.
B	Atmung unauffaellig, SpO2 98% an Raumluft.
C	Kreislauf stabil, kleine Schuerfwunde Stirn (geringe Blutung). Keine Zeichen von Schock.
D	Wach, orientiert, GCS 15. Keine neurologischen Ausfaelle.
E	Leichter HWS-Schmerz 3/10, keine weiteren Verletzungen. Umgebung: auslaufende Betriebsstoffe (Rutsch-/Brandgefahr) und Verkehrschaos an Kreuzung.

SAMPLER Anamnese

S	Symptoms: Leichter Nackenschmerz, kleine Kopfscheuerfung, sonst beschwerdearm.
A	Allergies: Keine bekannt.
M	Medications: Keine.
P	Past medical history: Keine bekannten Vorerkrankungen.
L	Last intake: Kaffee vor ca. 1 h.
E	Events: Auffahrunfall, Airbag ausgelöst, angeschnallt, keine Bewusstlosigkeit.
R	Risk factors: Kein Alkoholhinweis. Nichtraucher (laut Patient).

Interne Übungsunterlage - Patientenkarte P4 - Stand: 2026-02-24

Patientenkarte P4 - Rückseite

DIES IST EINE ÜBUNG DES BRK

**Bitte lassen Sie diesen Zettel an der Position
liegen.**

Vielen Dank für Ihre Unterstützung.

Hinweis: Keine Gefahr. Es handelt sich nicht um einen echten Notfall.

In einem echten Notfall: 112

Szenario: Neurologischer Ausfall (Sprachstoerung/Armschwaeche)

Name	Jürgen Krämer
Alter	72 Jahre
Geschlecht	männlich
Fundort (what3words)	///familienname.haltung.aufdeckung

Vitalparameter	
RR	198/104 mmHg
HF	92 /min
AF	18 /min
SpO2	95% (RA)
Temp	36.5 C
GCS	14 (E4 V4 M6)
BZ	118 mg/dl

Beschwerden / Befund
• Nachbar findet Patient morgens auf dem Sofa: Sprache verwaschen, rechte Gesichtshaelfte haengt, rechte Hand/Arm schwaecher. • Patient wirkt verlangsamt, kann Fragen nur teilweise beantworten. Kein Sturz bekannt. • Zeitpunkt Beginn unklar: heute Morgen bemerkt; zuletzt gestern Abend unauffaellig gesehen.

ABCDE Schema (Befundorientiert)

A	Atemwege frei, deutliche Dysarthrie. Schluckstoerung moeglich; Aspirationsrisiko beachten.
B	Atmung unauffaellig, SpO2 95% an Raumluft.
C	Kreislauf stabil, ausgepraegte Hypertonie. Puls regelmaessig tastbar.
D	Neurologische Auffaelligkeiten: Sprachstoerung, Fazialisparese rechts, Armschwäche rechts. Bewusstsein leicht getruebt (GCS 14).
E	Keine sichtbaren Verletzungen, kein Fieber. BZ 118 mg/dl.

SAMPLER Anamnese

S	Symptoms: Sprachstoerung, rechte Armschwaeche, Gesichtshaenge rechts.
A	Allergies: Keine bekannt.
M	Medications: Apixaban, Ramipril, Metformin (laut Medikamentenplan).
P	Past medical history: Vorhofflimmern, Hypertonie, Diabetes Typ 2.
L	Last intake: Unklar; Fruehstueck heute noch nicht gegessen (laut Nachbar).
E	Events: Heute Morgen auffaellig; zuletzt gestern Abend gegen 22:00 Uhr normal (Beginnzeit unklar).
R	Risk factors: Antikoagulation, Vorhofflimmern, Hypertonie.

Interne Übungsunterlage - Patientenkarte P5 - Stand: 2026-02-24

Patientenkarte P5 - Rückseite

DIES IST EINE ÜBUNG DES BRK

**Bitte lassen Sie diesen Zettel an der Position
liegen.**

Vielen Dank für Ihre Unterstützung.

Hinweis: Keine Gefahr. Es handelt sich nicht um einen echten Notfall.

In einem echten Notfall: 112

Szenario: Brustschmerz / Unwohlsein (unklare innere Ursache)

Name	Sabine Lutz
Alter	56 Jahre
Geschlecht	weiblich
Fundort (what3words)	///obernum.kranz.wählen

Vitalparameter	
RR	104/68 mmHg
HF	112 /min
AF	22 /min
SpO2	93% (RA)
Temp	36.2 C
GCS	15
BZ	156 mg/dl

Beschwerden / Befund
• Plötzlich einsetzender Druck/Enge retrosternal, Ausstrahlung linker Arm und Kiefer, Uebelkeit und Kaltschweissigkeit. • Beginn vor ca. 35 Minuten beim Tragen von Einkaufstueten; Antazidum ohne Besserung. • Patientin wirkt ängstlich, blass und schwitzig. Kein Sturz, keine Verletzung.

ABCDE Schema (Befundorientiert)

A	Atemwege frei, spricht in ganzen Sätzen.
B	Leichte Dyspnoe, AF 22/min, SpO2 93% an Raumluft.
C	Tachykardie, RR 104/68 (grenzwertig). Haut kalt/feucht, Rekap leicht verzögert.
D	Wach und orientiert, deutlich ängstlich. Kein neurologisches Defizit.
E	Keine sichtbaren Verletzungen. Anhaltender Thoraxdruck 8/10, kaltschweissig.

SAMPLER Anamnese

S	Symptoms: Thoraxdruck/Enge 8/10, Ausstrahlung li. Arm/Kiefer, Uebelkeit, Schweissausbruch.
A	Allergies: Aspirin/ASS (Hautausschlag).
M	Medications: Metoprolol, Atorvastatin; Nitrospray vorhanden (laut Patientin).
P	Past medical history: KHK mit Stent (2021), Hypertonie, Hyperlipidaemie.
L	Last intake: Kaffee und Toast vor ca. 2 h.
E	Events: Beginn bei Belastung (Einkauf getragen), seitdem anhaltend.
R	Risk factors: Raucherin, positive Familienanamnese (laut Patientin).

Interne Übungsunterlage - Patientenkarte P6 - Stand: 2026-02-24

Patientenkarte P6 - Rückseite

DIES IST EINE ÜBUNG DES BRK

**Bitte lassen Sie diesen Zettel an der Position
liegen.**

Vielen Dank für Ihre Unterstützung.

Hinweis: Keine Gefahr. Es handelt sich nicht um einen echten Notfall.

In einem echten Notfall: 112